

ジアゼパム換算は こう使う

研修医 / 薬剤師向け

ベンゾ等価換算表と
『換算できない睡眠薬』



これだけは押さえる3点



①

基準 =
ジアゼパム 5mg

すべての薬をこの量の
何倍かで表す

②

換算できる =
ベンゾ・Z薬

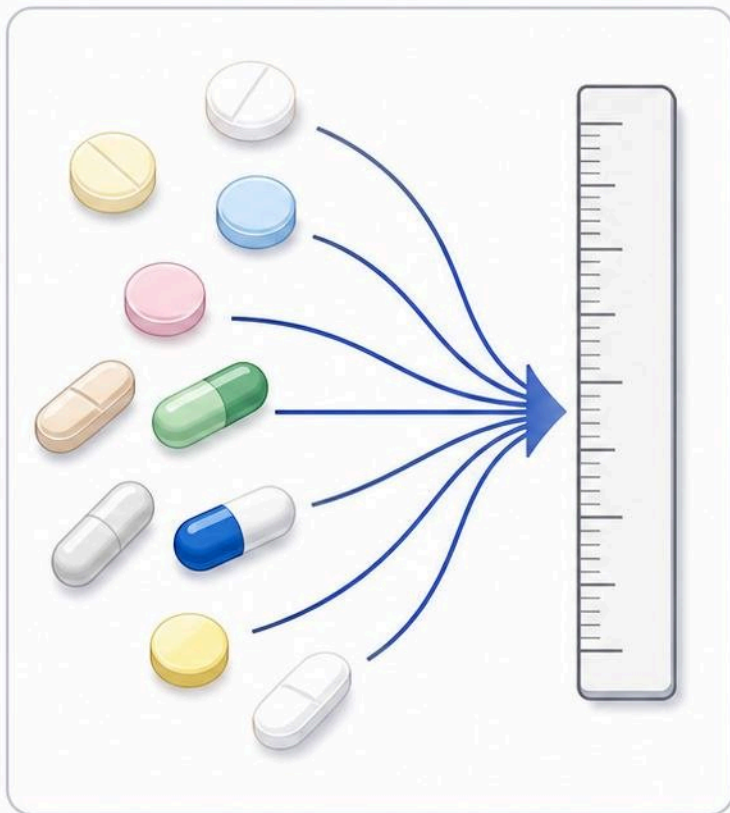
GABA-A受容体に
作用する薬

③

換算できない =
デエビゴ・ロゼレム

ベルソムラも。
機序が異なる

ジアゼパム換算とは



力価の違う薬を
『ジアゼパム何mg分』に統一する

① 基準 = ジアゼパム 5mg

② 出典 = 稲田・稲垣『向精神薬の等価換算』(jsprs)

主に国内の比較試験に基づく / あくまで『目安』

ジアゼパム換算 3つの用途

1



**減薬時の
長時間型置換**

短時間型→ジアゼパムへ

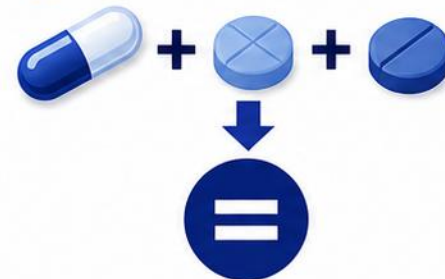
2



力価（強さ）の比較

共通単位で強弱がわかる

3



多剤併用の総量評価

合計ジアゼパム相当量

早見表① 抗不安薬（ジアゼパム5mg相当）

一般名（商品名）	ジアゼパム5mg相当量
エチゾラム（デパス）	1.5mg
アルプラゾラム（ソラナックス）	0.8mg
ロラゼパム（ワイパックス）	1.2mg
ブロマゼパム（レキソタン）	2.5mg
クロナゼパム（リボトリール）	0.25mg 高力価

値が小さいほど **高力価**（少量で同等）

早見表② 睡眠薬・Z薬（ジアゼパム5mg相当）

一般名（商品名）	ジアゼパム5mg相当量	
トリアゾラム（ハルシオン）	0.25mg	
ブロチゾラム（レンドルミン）	0.25mg	
フルニトラゼパム（サイレース）	1mg	
ゾルピデム（マイスリー）	10mg	Z薬
エスゾピクロン（ルネスタ）	2.5mg	Z薬

Z薬 は非ベンゾだが **BZ受容体作動** → 換算表に載る

表の読み方とZ薬の位置づけ

値が小さい = 高力価 (少量で同等)



Z薬は『換算できる』が、
依存・耐性・受容体選択性はベンゾと異なる /
換算できる ≠ 完全に同等

換算表に載らない睡眠薬

デエビゴ

(レンボレキサント)

換算不能

ベルソムラ

(スボレキサント)

換算不能

ロゼレム

(ラメルテオン)

換算不能

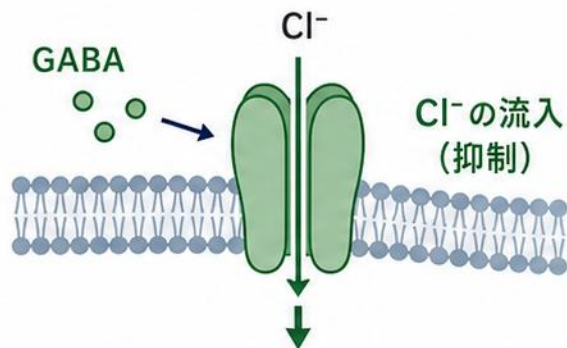
GABA-A

⚠ 表の不備ではなく『原理的に換算できない』

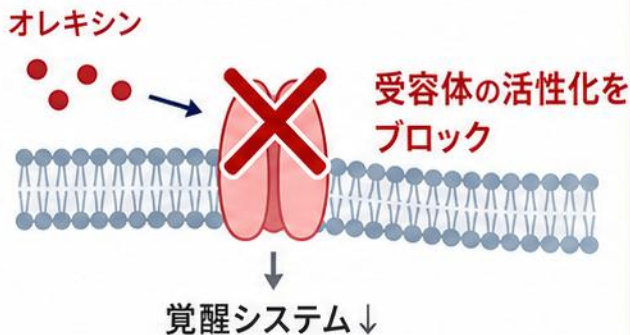
なぜ換算できないのか — 機序の違い

原則**等価換算 = 同じ受容体への相対力価が前提**

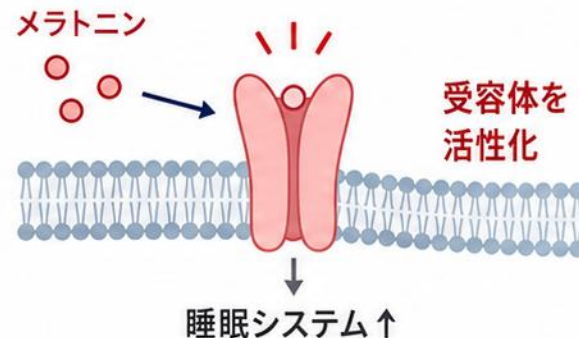
① ベンゾ・Z薬

→ GABA-A受容体作動**換算できる**

② DORA

**→ オレキシン受容体を遮断
(覚醒を抑える)****換算できない**

③ ラメルテオン

→ メラトニン受容体を刺激**換算できない****②③はGABA-A非依存 → 共通の物差しが無い**

換算できる薬／できない薬

換算できる



GABA-A作動

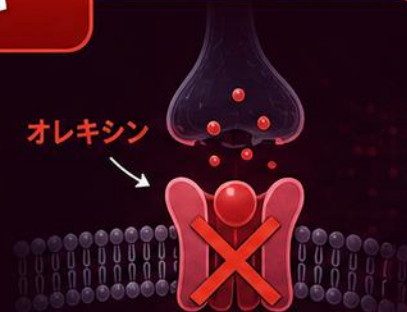
ベンゾジアゼピン

Z薬

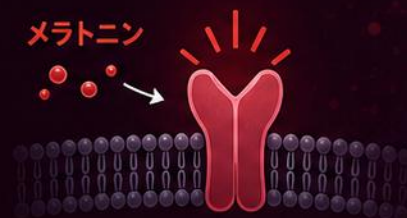


換算できない

オレキシン拮抗
(DORA)



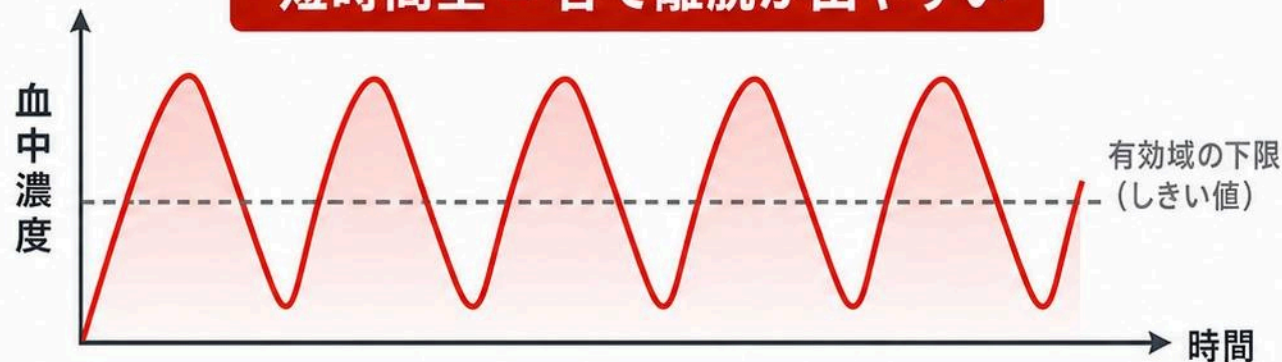
メラトニン作動



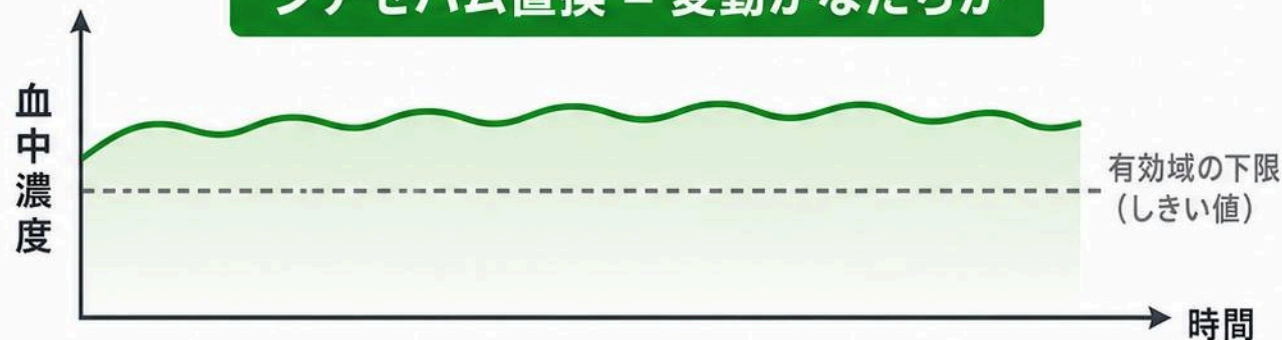
切替は『換算』でなく『ベンゾ漸減＋新規薬の置換』

ジアゼパム置換による減薬（Ashton法）

短時間型 = 谷で離脱が出やすい



ジアゼパム置換 = 変動がなだらか



減薬の手順（Ashton法）

- 1 等価換算で
長時間型ジアゼパムへ
置換
- 2 数週～数か月で
緩徐漸減

減薬ガイドラインの推奨

1



65歳以上 →

使用期間を問わず
緩徐な漸減を提案

2



18～64歳 →

4週超の使用で
漸減を提案



漸減は中止成功率を高め、重篤な害は伴わない

今も使われているのか — 現在地

✓ 今も現役の用途

- ✓ 換算は現役
- ✓ 減薬の置換
- ✓ 総量評価
- ✓ 力価比較



⚠ 適正使用へ



ベンゾは**高齢者で
特に慎重投与**



漫然投与を避け
適正使用へ



換算 = 安全に減らすための道具

Take Home

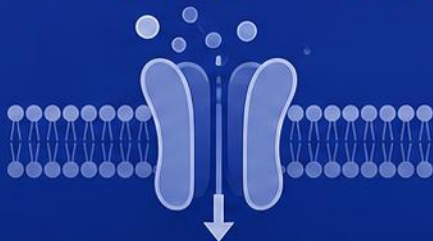
①

基準 =
ジアゼパム 5mg



②

ベンゾ・Z薬 =
GABA-A作動
→ 換算できる



③

デエビゴ・
ベルソムラ・
ロゼレム =
換算できない



医知創造ラボ



チャンネル登録・高評価をお願いします